

Poignet traumatique aux urgences

Mécanisme du trauma, main dominante
Recherche troubles neuro-vasculaires
Recherche oedème, tuméfaction
Zones douloureuses à la palpation
Pas de testing des mobilités avant Rx ++

Plaie en regard d'une fracture = fracture ouverte
Vaccins (status VAT) + ATB
En cas de fort déplacement et/ou compression nerveuse
(parésie, paresthésies, dysesthésie, hypoesthésie) =>
réduction au doigtier japonais

Extrémité distale du radius (EDR) : Rx F+P

Pas de fracture : ENTORSE

- **Degré I** (légère) : peu d'oedème, peu de douleur, bonne mobilité => attelle palmaire 7j puis réévaluation
(pas d'attelle velcro) - **Contrôle chir main à J7**
- **Degré II** (modérée) : oedème hématoïde, diminution partielle des amplitudes articulaires
- **Degré III** (sévère) : oedème important, hématoïde, diminution importante des amplitudes articulaires
=> attelle palmaire 3 semaines - **Contrôle chir main à 2-3 semaines**
Risques : une fracture occulte (in situ) sera plus visible à 2 sem
- Atteinte des ligaments intrinsèques ou extrinsèques du carpe
- Atteinte du TFCC : complexe fibro-cartilagineux triangulaire ulno-carpien

Fracture extra-articulaire

In situ ou peu déplacée :
=> attelle palmaire position neutre **Contrôle chir main < J7**
PEC chirurgicale si :
- bascule dorsale > 10°
- toute bascule palmaire
- variance ulnaire positive (radius raccourci vs controlat)
=> PEC CHIR - attelle palmaire dans l'attente

Fracture intra-articulaire + Rx 2 obliques

- In situ : discuter CT si doute sur escalier
=> attelle palmaire 4 semaines
Contrôle chir main < J7
- Déplacée : probable CT
=> PEC CHIR - attelle palmaire dans l'attente

Trauma du Scaphoïde

Suspicion clinique = douleur à la palpation de :
- 1/3 moyen = tabatière anatomique en inclinaison ulnaire
- 1/3 distal = tubercule palmaire (distal au poulx radial)
- 1/3 proximal = 1cm en distal du tubercule de Lister
Douleur à l'inclinaison ulnaire (VPN ++ à 72h)
Piston du pouce : Se et Sp faibles !

Pas de fracture : Suspicion clinique de fracture occulte

Attelle palmo-radiale en position neutre
Contrôle chir main à 2-3 semaines
Info au patient : en cas de susp clinique = traitement par immobilisation

Fracture du scaphoïde

1/3 proximal : PEC CHIR car risque de pseudarthrose
1/3 moyen :
- in situ : attelle palmo-radiale > 8 sem
- déplacée : PEC CHIR
1/3 distal : attelle palmo-radiale
Contrôle chir main 4-6 sem

Abréviations : CM = chir main, VAT = vaccin anti tétanique, FPL = flexor pollicis longus, EPL = extensor pollicis longus, APB = abductor pollicis brevis, IOD = inter osseus dorsaux, ADM = abductor digiti minimi, IP = inter phalangienne



Service des urgences

Chirurgie de la main aux urgences



Guide médical de prise en charge des pathologies traumatiques du poignet et de la main.

Alexandre Bentvelzen
Laurent Wehrli

15.02.2019 V.1.1

Validation : Direction du Service des Urgences
Février 2019
Durée de validité : 02.2021



CIR104445

Plaies de la main aux urgences

Anamnèse : Latéralité, profession (âge, sexe), date et heure de la plaie, dernier repas, status VAT, circonstances de survenue

Morphologie plaie : Site, taille, orientation, berges nettes, contuses, dilacérées, perte de substance, plaie punctiforme = risque infectieux

Vascularisation

Couleur (rose, blanc, bleu)
Chaleur (versus controlatéral)
Recoloration capillaire et turgescence

Tendons

Mobilité active globale
Cascade physiologique au repos
Effet ténodèse
Testing des fléchisseurs superficiels et profonds + FPL
Testing des extenseurs communs, propres du II et V, EPL, APB, IOD, ADM

Sensibilité

Hypoesthésie au toucher
D2Ps (discrimination aux 2 points statique)
< 4 mm = normal
4-6mm = douteux
>6mm = pathologique

Avis spécialisé si : dévascularisation, trouble de la sensibilité, plaie palmaire profonde, déficit de la mobilité active, infection profonde

Plaie palmaire

Pas d'exploration d'une plaie palmaire aux urgences

Observation simple macroscopique des lésions
Lavage abondant +/- parage des berges
Si lésion suspectée cliniquement : Points de rapprochement + immobilisation dans l'attente d'une PEC chir main
Si pas de lésion suspectée cliniquement et plaie superficielle simple : suture simple
Prolene 4.0
Dans tous les cas, réévaluation CM à 24-48h

Plaie dorsale

Parage des berges a minima (0,5mm)
Ablation d'un éventuel corps étranger
Lavage abondant +++ (intra articulaire si arthrotomie traumatique à **rechercher systématiquement**)
En l'absence de lésion retrouvée : Suture simple
CAVE : décalage lésion peau/lésion tendon
Si lésion suspectée : points de rapprochement, immobilisation dans l'attente d'une PEC CM
Documenter le % en largeur de section tendineuse
Si extension chirurgicale de la plaie : a minima et progressive, purement longitudinales en dorsal

Morsures ou plaies souillées

Anamnèse : charge bactérienne (animal, plaie agricole, couteau à viande...), VAT, facteurs de risque infectieux (aspénie, diabète, curage ganglionnaire...)

Signes de Kanavel pour phlegmon des gaines des fléchisseurs (doigt en légère flexion, fusiforme, douleur le long de la gaine des fléchisseurs, douleur à l'extension passive du doigt)

Lavage abondant eau + savon
Rx (si relevant)

Débridement, parage des berges (0,5mm) aux urgences

Rinçage NaCl > 100ccc ++

Pas de suture +++

Morsure de chat

S'infecte dans 50% des cas (Pasteurella multocida ++)
Augmentin 1gx2/j si prophylaxie, 1gx3/j si curatif 7j
Si allergie : Dalacine 600mgx3 + Ciprofloxacine 500mgx2 (CAVE : fonction rénale)
ou Dalacine 600mgx3 + Bactrim forte 1cpx3

Morsure de chien

S'infecte dans 20% des cas
Antibioprophyllaxie : idem chat
Déclaration cantonale obligatoire (information sur chien et propriétaire)

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privée/animaux/fichiers_pdf/V4__DGAV_AffVet_Annonce_morsure_chien_s_humain.pdf

Morsure humaine

Pas de prophylaxie HIV (sauf si du sang dans la bouche)
Status vaccinal hépatite B
Antibioprophyllaxie : idem chat

Trauma digital aux urgences : Rx F+P strict +/- oblique

Doigt II à V : Topographie douleur, hématome, tuméfaction, déformation

Métacarpe - MP

Pas de fracture = **Entorse**
Plâtre IP libres 3 semaines
Contrôle CM à 7j
Si instable => CHIR

Fracture extra articulaire
Recherche **DEROTATION** !
Dérotation => CHIR
Fracture instable (transverse, oblique, spiroïde) => CHIR
Fracture stable sans dérotation :
Plâtre IP libres 4 semaines et contrôle CM à 7j

Fracture intra articulaire
= # in situ ou déplacée
Faire Rx 2e oblique
=> CHIR

P1 - IPP - P2

Pas de fracture = **Entorse IPP**
Attelle digitale GDS 2-3 sem
Contrôle CM à 7-10j

Fracture in situ sans dérotation
Attelle digitale ou palmo-digitale
4 semaines
Contrôle CM à 7j

Fracture déplacée et/ou dérotation
=> CHIR

Luxation dorsale IPP
Réduction sous AL
SANS DISTRACTION
hyperextension -> compression axiale -> flexion P2 sur P1
Attelle GDS IPP (IPP libre) 3sem
Contrôle CM <7j

IPD - P3

Pas de fracture + pas de déformation = **entorse IPD**
Attelle digitale courte 2-3 sem
Contrôle CM à 7-10j
Pas de fracture mais déficit d'extension = **Mallet tendineux**
Attelle IPD en hyperextension stricte 10°
Contrôle CM à 8 sem

Arrachement osseux dorsal avec déficit d'extension = **Mallet osseux**
Attelle IPD à 0°
Contrôle CM 6 sem pour évaluer indication opératoire

Fracture extra articulaire
Attelle IPD 4 sem
Contrôle CM 7j

Pouce : Topographie douleur, hématome, tuméfaction, déformation

Métacarpo-phalangienne : Rx pouce F+P

Pas de fracture = **Entorse MP1**
Douleur/Laxité en hyperextension = **entorse plaque palmaire**
Attelle MP en semi flexion 3 sem - Contrôle CM 7-10j
Entorse du LCU (lig collat ulnaire = pouce du skieur)
- **Stable** (inclinaison radiale < 30°, arrêt net)
Attelle palmo-radiale IP libre 3 sem
- **Instable** (inclinaison radiale > 30°, arrêt mou)
= suspicion de lésion de **Stener** => CHIR

Fracture base P1
Fracture/avulsion **in situ** = attelle palmo-radiale 4sem
Fracture/avulsion **déplacée** => CHIR
avulsion millimétrique = suspicion **Stener** (cf infra)

Luxation dorsale MP
Réduction sous AL SANS DISTRACTION ++
hyperextension -> compression axiale -> flexion MP
Attelle MP en semi flexion 3 sem
Contrôle CM 7-10 jours

Base M1 - Trapézo-métacarpienne : Rx TM F+P

Pas de fracture = **Entorse TM**
- **Stable** = attelle palmo-radiale IP libre 2-3 sem
Contrôle CM à 7-10j
- **Instable** : tiroir trapézo-métacarpein (TM) antéro-post ou latéral = CHIR

Fracture
BENNETT déplacée => CHIR
ROLANDO => CHIR
WINTERSTEIN (extra-articulaire)
≈ 30° => CHIR
α< 20° => attelle palmo-radiale TM en extension 4sem
Contrôle CM à 7-10j



Bennett



Rolando



Extra-articulaire